

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DISEJECUTIVO - VERSIÓN ESPAÑOLA (DEX-SP)

Eje V: Neurocognición y Síndrome Disejecutivo • Batería BADS de Wilson y Validación de Pedrero-Pérez

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario Disejecutivo, Versión Española (DEX-Sp; autoinforme e informante).
Nombre Original	Dysexecutive Questionnaire (DEX, subprueba de la batería BADS; Wilson et al., 1996).
Autores Originales	Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie y Jonathan J. Evans.
Adaptación Hispana	Javier Pedrero-Pérez, J. M. Ruiz-Sánchez de León, et al. (Madrid Salud / Proyecto Hombre, 2009, 2011).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Quejas cotidianas del síndrome disejecutivo cognitivo y conductual.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme ecológico (con versión complementaria para informantes).
Composición de Ítems	20 ítems puntuados en escala tipo Likert de 5 puntos (0 a 4; rango 0 a 80 puntos).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años); validado en población comunitaria, adicciones y daño cerebral adquirido.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de cumplimentación autónoma o guiada por examinador.
Régimen de Licencia	Instrumento original en batería BADS (Pearson Assessment); versión española de uso libre clínico.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL SÍNDROME DISEJECUTIVO COTIDIANO

El **DEX** fue desarrollado en el seno de la Batería de Evaluación Conductual del Síndrome Disejecutivo (BADS; Wilson et al., 1996) para medir el impacto de las alteraciones prefrontales en la vida real:

1. **Complementariedad Ecológica:** Los pacientes con daño prefrontal o disfunción ejecutiva suelen rendir dentro de rangos normales en pruebas psicométricas altamente regladas, pero fracasan en su vida sociolaboral debido a fallos de autorregulación.
2. **Doble Dimensión Clínica:** La adaptación española (Pedrero-Pérez et al., 2011) confirmó un modelo bifactorial que distingue los déficits cognitivos de desorganización frente a los desajustes conductuales de impulsividad y agresividad.
3. **Anosognosia y Anosodiaforia:** Permite cuantificar la conciencia del déficit comparando la puntuación de autoinforme del paciente con la cumplimentada por un familiar u observador cercano.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS

Dimensión Factorial	Ítems DEX-Sp	Manifestaciones Clínicas Exploradas en la Vida Cotidiana
Desorganización y Apatía (Factor 1: Cognitivo)	1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20 (12 ítems)	Problemas de planificación temporal, lentitud ideatoria, fallos de memoria prospectiva, falta de iniciativa autónoma, distracción y perseveración en conductas rígidas.
Desinhibición e Impulsividad (Factor 2: Conductual)	2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 18 (8 ítems)	Pérdida de control de impulsos, estallidos de agresividad verbal, desinhibición social, hiperactividad motriz, labilidad afectiva y respuestas emocionales desmedidas.
Puntuación Total Global	20 ítems combinados	Índice global de gravedad del síndrome disejecutivo percibido (rango total 0 a 80 puntos).
Discrepancia Autoinforme - Informante	Diferencial delta	Medida cuantitativa de anosognosia: $\Delta = \text{Puntuación Informante} - \text{Autoinforme}$ ($\Delta > 12$ puntos denota anosognosia severa).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las investigaciones de validación española (Pedrero-Pérez et al., 2009, 2011; $N = 794$) aportan amplia evidencia de solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.89 - 0.91	Excelente confiabilidad en población clínica con adicciones y daño cerebral.
Confiabilidad en Factores	Alfa = 0.86 (F1) / 0.80 (F2)	Elevada consistencia interna independiente en ambas dimensiones clínicas.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.84 (intervalo 1 mes)	Alta reproducibilidad en pacientes estables y en controles comunitarios.
Validez Concurrente	$r = 0.52 - 0.64$ con BIS-11	Correlación moderada a alta con escalas de impulsividad y sintomatología frontal.
Validez Discriminante	Efecto $d = 0.85 - 1.25$	Diferencia nítidamente pacientes con adicciones o TCE de sujetos sin patología.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Ponderación de Respuestas:** Cada reactivo se evalúa en una escala ordinal: 0 = Nunca, 1 = Rara vez, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Casi siempre.
- **Cálculo de Puntuación Total:** Sumatoria de los 20 reactivos:

$$\text{Puntuación Total DEX-Sp} = \sum_{i=1}^{20} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 80 puntos})$$

- **Cálculo por Factores:** Factor 1 (Desorganización/Apatía, 0 a 48 pts) y Factor 2 (Desinhibición/Impulsividad, 0 a 32 pts).
- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor severidad de síntomas disejecutivos cotidianos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Percentil	Interpretación y Gravedad Disejecutiva (Pedrero-Pérez)
Sin Síntomas	0 a 19 puntos	$P \leq 50$	Rendimiento ejecutivo preservado; ausencia de quejas relevantes.
Quejas Leves	20 a 28 puntos	$P = 51$ a 84	Variabilidad normativa normal; quejas atencionales aisladas no patológicas.
Disfunción Moderada	29 a 34 puntos	$P = 85$ a 94	Punto de corte de riesgo afectación disejecutiva que interfiere en la vida.
Disfunción Severa	≥ 35 puntos	$P \geq 95$	Punto de corte patológico severo colapso disejecutivo global observable.

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS EN ESPAÑA (POBLACIÓN COMUNITARIA VS. CLÍNICA):

En la población general española no clínica, la media se sitúa en **19.4 puntos (DE = 10.2)**. El punto de corte de **29 puntos (P85)** identifica disfunción ejecutiva moderada. En muestras clínicas con adicciones o traumatismo craneoencefálico, la media asciende a **28.6 puntos (DE = 13.8)**, siendo **≥ 35 puntos (P95)** indicador de severo deterioro conductual.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y MANEJO DE LA ANOSOGNOSIA

PROTOCOLO CLÍNICO MULTIMÉTODO CON EL DEX-SP:

- **Paso 1 (Administración Dual):** Administrar simultáneamente el DEX-Sp de autoinforme al paciente y la versión para informantes a un conviviente cercano.
- **Paso 2 (Análisis del Índice de Discrepancia Δ):**
 - **Discrepancia Neutra** ($|\Delta| \leq 5$): Buena concordancia y adecuada autoconciencia del estado cognitivo.
 - **Discrepancia Positiva Marcada** (Informante – Autoinforme ≥ 12 puntos): Sospecha fundada de **anosognosia o anosodiaforia prefrontal**; el paciente minimiza déficits evidentes para el entorno. Priorizar reporte de informante.
 - **Discrepancia Negativa Marcada** (Autoinforme – Informante ≥ 12 puntos): Típica de trastornos afectivos (depresión mayor, ansiedad); sobreestimación de fallos por sesgo rumiativo.
- **Paso 3 (Focalización Terapéutica):** Si predomina el Factor 1, entrenar en planificación externa y listas de tareas; si predomina el Factor 2, pautar manejo conductual de contingencias y control de estímulos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO Y ANOSOGNOSIA

Identificación: Varón de 34 años, operario de almacén, evaluado a los 9 meses de un traumatismo craneoencefálico frontal moderado tras accidente laboral. La empresa solicita valoración neuropsicológica por quejas de discusiones continuas con compañeros y abandono recurrente de tareas antes de finalizarlas.

Evaluación con DEX-Sp:

- **Autoinforme del Paciente:** Puntuación Total = **14 puntos** (rango normal, sin conciencia de problemas; Factor 1 = 8, Factor 2 = 6).
- **Informante (Cónyuge):** Puntuación Total = **48 puntos (severamente patológico, Percentil > 99; Factor 1 = 28, Factor 2 = 20).**
- **Discrepancia Anosognósica:** $\Delta = 48 - 14 = +34$ puntos (anosognosia prefrontal masiva).

Exploración Complementaria: Tests formales de laboratorio (WCST y Stroop) mostraron caídas moderadas en perseveraciones, pero el DEX-Sp del informante destapó la verdadera magnitud del desajuste conductual cotidiano (desinhibición verbal y apatía en el hogar).

Intervención: Programa de neuro-rehabilitación centrado en insight progresivo asistido por vídeo, reestructuración ambiental en el puesto de trabajo y psicoeducación para la familia.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FALSA NORMALIDAD POR ANOSOGNOSIA:

En lesiones frontomediales y adicciones crónicas, un autoinforme normal con quejas familiares severas indica falta de insight, no ausencia de déficit.

SESGO AFECTIVO EN DEPRESIÓN:

Pacientes con distimia o depresión puntúan muy alto en el autoinforme del DEX-Sp debido a su autofocalización negativa, sin daño cerebral primario.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H., & Evans, J. J. (1996). *Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)*. Thames Valley Test Company.
2. Pedrero-Pérez, E. J., Ruiz-Sánchez de León, J. M., et al. (2011). Versión española del Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp): propiedades psicométricas en adictos y población general. *Adicciones*, 23(3), 213-222.
3. Pedrero-Pérez, E. J., et al. (2009). Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp): fiabilidad y validez en adictos a sustancias. *Revista de Neurología*, 48(12), 617-622.
4. Burgess, P. W., Alderman, N., et al. (1998). The Dysexecutive Questionnaire. In *Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome*. Bury St Edmunds.